

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	皮膚癌 Skin cancer				
編號	A31000-Q03-W-K20	制定者	N16 蔡富卿	公布日期	99 年 01 月 20 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 12 月 17 日
版本/總頁數	第 3.7 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員了解皮膚癌的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與護理措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

皮膚癌是指細胞產生惡性變化，使鄰近組織及器官受到嚴重毀損，是歐美白色人種最常罹患之癌症。由於皮膚癌容易發現，故治癒率高。皮膚癌分為三種：1.基底細胞癌，約佔 70-80%，是最常見的皮膚癌，是三者中最良性的。2.鱗狀細胞癌，約佔 20%，是第二常見皮膚癌 3.惡性黑色素瘤，佔很少比例，是三者中最惡性的。前兩種都可以透過活體組織切片及細胞學檢查診斷出來，治癒率有 95~98%，但再發率有 36%。

（二）症狀

1.基底細胞癌(Basal Cell Carcinoma；BCC)：為一種進行緩慢、無轉移性的皮膚腫瘤，是皮膚癌最常見的一種。在各個年齡層都可以發現，50~60 歲男性及曬太陽者容易出現，常見發生在面、頸部。臨床表徵：病變處呈扁平或結節狀，顏色為肉色或黑色，具脂（蠟）樣光澤、中心下陷的小結節或有屑性斑塊，最後成潰瘍狀，故又稱侵蝕性潰瘍，會侵蝕骨骼及軟骨。

主題名稱	皮膚癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K20	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/8

2.鱗狀細胞癌(Squamous Cell Carcinoma；SCC)：是由表皮細胞惡性增生而來又稱為表皮樣癌，速度快、會轉移，容易發展成蕈樣狀腫塊，好發於陽光照射皮膚部位，如臉部及手臂，或是有慢性發炎刺激的皮膚。臨床表徵：剛開始為紅斑、有滲液、帶鱗屑的斑塊，或底部突起的表淺性硬疣丘疹。隨著病情進展，病灶處範圍擴大，呈結節狀、潰瘍。

3.惡性黑色素瘤(Malignant Melanoma)：為黑色素細胞異常生長所致，轉移速度快且致死率高。在台灣最常見的是肢端型，常長於手掌、腳掌或指甲下面，表面上就像深黑色的痣，但顏色分布不均勻且形狀不規則，黑褐色有時會轉變成紅色、藍色甚至白色。

(三) 常見檢查

發現皮膚上有不尋常的贅生物、潰瘍或腫塊顏色、形狀改變、容易流血、結痂或傷口不易癒合等等，都應經醫師診斷。一般而言，醫師只要詳細觀察腫瘤的形狀和顏色，加上病史通常就能初步診斷此贅生物、痣或顏色的改變是否有惡性變化的可能性，若有需要醫師會建議取一塊組織在顯微鏡下檢查來確定診斷。

(四) 常見治療

1. 基底細胞癌：手術切除、放射治療、冷凍療法、電燒法或刮除術。
2. 鱗狀細胞癌：手術切除、放射治療、化學治療、莫氏顯微手術。
3. 惡性黑色素瘤：手術切除、局部及全身性化學治療或輔助性免疫療法、標靶治療。

(五) 護理問題

- 1.組織狀態不完整／惡性腫瘤病灶有關。
- 2.易感染／接受化學或放射線治療有關。
- 3.疼痛不適／手術切除病灶有關。

(六) 護理措施

- 1.組織狀態不完整／惡性腫瘤病灶有關

(1)每日評估記錄傷口變化，如：出血、滲液、顏色及味道，傷口滲濕時予以

主題名稱	皮膚癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K20	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/8

換藥。

(2)教導保持傷口清潔乾燥，避免壓迫傷口並教導或使用刺激性製劑。

(3)依醫囑按時給予抗生素使用。

(4)依醫囑以無菌技術換藥。

(5)教導選擇高蛋白、高維生素飲食，以促進傷口修復再生。

(6)若切除部位在口腔附近，則告知病患以吸管飲水，並減少臉部運動、少說話，教導清淡飲食、口腔護理。

2.易感染／接受化學或放射線治療有關

(1)密切監測生命徵象，當出現發燒症狀須立即告知醫師。

(2)密切監測全血球計數，當出現骨髓抑制副作用，須採保護性隔離措施。

(3)密切監測輸液注射部位有無感染症狀，並教導維持輸液的通暢性。

(4)密切監測藥物副作用，並衛教藥物注意事項及可能之副作用。

(5)避免侵入性治療，如有必要採無菌技術執行。

(6)避免與上呼吸道感染或有傳染病的病人、家屬、工作人員或訪客接觸。

3.疼痛不適／手術切除病灶有關

(1)三班以疼痛評估數字量表，評估病人疼痛程度，記錄並觀察疼痛部位、性質、持續時間、疼痛加重及緩解因子。

(2)給予適當的疼痛解決方法，如更換傷口前用生理食鹽水沖濕，再將紗布移除減輕傷口疼痛。

(3)依醫囑給予止痛劑，並評估藥物之效果，適時與病人討論止痛劑使用時機。

(4)教導放鬆技巧如：深呼吸、背部按摩、冥想或予轉移注意力如：音樂、閱讀、聊天，以減輕疼痛。

(5)避免因任何姿勢不當所導致的傷口牽扯或壓迫。

(6)教導病人穿著舒適寬鬆的衣褲，避免傷口摩擦導致疼痛不適。

(7)提供適當支托予以舒適臥位及抬高患肢減輕腫脹疼痛。

主題名稱	皮膚癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K20	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/8

(七) 衛教指導

1. 術後傷口照護

- (1)維持良好血液循環，避免傷口壓迫、磨擦或牽扯。
- (2)保持傷口清潔乾燥，若有髒污或滲濕情況，應立即告知醫護人員。
- (3)盡量勿碰撞傷口，如須接觸傷口前後需洗手。
- (4)給予飲食衛教，高蛋白質食物來源：魚、肉、蛋、豆、奶及其製品；高維生素食物來源：柳橙、橘子等柑橘類水果及盡量攝取水份約每日 2000cc 以上。

2. 化學治療注意事項

- (1)注射化療藥物期間，如有任何不適症狀，如：嚴重嘔吐、呼吸急促、心悸或其他身體不適，請告知醫護人員。
- (2)注射化療藥物期間，勿任意調整滴速，以免影響治療效果或增加毒性作用程度。
- (3)如化學治療藥物滲出血管造成皮膚發紅、腫脹、發熱及疼痛等現象，請告知醫護人員處理。
- (4)如化療藥物不慎濺漏到皮膚上，請立即告知醫護人員，並同時利用大量清水清洗藥物外漏部位。

3. 放射線治療注意事項

- (1)接受照射部位所作之記號須保留至治療結束，不可洗掉，若模糊不清時，應立即告知醫師重新標示。
- (2)應選擇寬鬆柔軟、棉、麻類織品、易吸汗的衣服，避免穿著粗糙或過緊的衣服，以減少治療部位因摩擦造成不適。
- (3)使用溫水清潔皮膚，避免用肥皂清洗或摩擦，再以柔軟的布輕拍、擦拭治療部位的皮膚。
- (4)治療部位不可使用任何的化妝品、清潔劑、保養品及藥品等，除非是醫師給予的處方。
- (5)避免治療部位受到強光、熱、寒風的刺激，可以使用傘或帽子遮陽。

主題名稱	皮膚癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K20	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/8

(6)多攝取高熱量及高維生素的食物，以增加皮膚修復能力。

(7)治療部位如有傷口未癒合，請醫師檢查後再決定是否要繼續接受治療。

(8)避免感染及出血：避免出入公共場所或接觸已受到感染的人，平時戴口罩

隔離、應避免碰撞受傷，可使用電動刮鬍刀刮鬍子及選擇軟毛牙刷刷牙。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 羅美婷、徐雯娟(2013)・照顧一位皮膚癌合併惡性葷狀傷口病人的護理經驗・新台北護理期刊，15(2)，105-112。
- (二) 林聖堯、鄭詩宗(2019)・皮膚癌的治療選項・高醫醫訊，39(6)，20-21。
- (三) 鄭百珊(2017)・易被忽視的皮膚癌前病變與皮膚癌・奇美醫訊，116，32-33。
- (四) 劉雪娥、馮容芬、李惠玲、方又圓、吳麗彬、周繡玲、劉莉妮、李薇莉、袁素娟、胡月娟、李嘉蕙、謝珮琳、陳瑋、楊玉娥、陳宇平、李和惠、曾月霞、陳淑芬、尹裕君、劉芹芳、謝家如(2020)・成人內外科護理（下）・華杏出版機構，1081-1084。
- (五) 許鈴宜（2020）。皮膚癌。聲洋防癌之聲，(166)，30-36。
- (六) 蔡新中、蔡新民（2017）。皮膚的病理變化。于博芮等編著，最新傷口護理學（三版，頁 21-22）。台北：華杏。
- (七) 黃靜君（2017）。營養評估與支持。于博芮等編著，最新傷口護理學（三版，頁

主題名稱	皮膚癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K20	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/8

99-130)。台北：華杏。

- (八) Kao, J. Y., Lee, C. N., Lee, J. Y. Y., & Lee, Y. C. (2018). Primary Cutaneous Carcinosarcoma of the Scalp - A Case Report. 臺灣整形外科醫學會雜誌, 27(1), 84-91.
- (九) Walsh, H. S., Hardwicke, J.,(2024). Non-melanoma skin cancer: diagnosis and current recommendations on management. Surgery (Oxford), 42(11), 820-826.

七、附件

(略)

主題名稱	皮膚癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K20	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.01.20	1.0	新制定。	99 年 01 月 20 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	檢視全文並修正用詞。	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	1.檢視全文修正錯字。 2.醫護部改護理部。	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	更新第六項參考文獻資料。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.2	1. 第三項第(一)、(二)、(六)目部份內容增修。 2. 新增參考文獻出處於內文中。 3. 增修第六項參考資料。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	3.5	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。

主題名稱	皮膚癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K20	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
110.10.07	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	3.6	1. 第三項第一、二目說明內容文字修訂。 2. 更新第三項第五、六目護理問題。 3. 新增第六項參考文獻資料。 4. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	3.7	更新第六項參考文獻資料。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
114.10.02	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	